Міністерство охорони здоров'я України Національна Академія Медичних наук України ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» м. Київ, вул. Академіка Шалімова 30	**НАПРАВЛЕННЯ *** на патологогістологічне дослідження	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 014/о Затверджена наказом МОЗ України 29.05.2013 р. № 435
№4488/26	**21.10.26** (дата і час направлення матеріалу)	

Відділення «**IV**» Медична карта стаціонарного хворого №10098/26
1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого: **Жерліцина Анастасія Станіславівна**
2. Стать: жін. 3. Вік: 1976 р.н. 4. Біопсія первинна
5. При повторній біопсії вказати № і дату первинної:
6. Дата і вид операції: **21.10.26 – Правобічна гемігепактомія. Холецистектомія.**
7. Маркування матеріалу, кількість об'єктів: 1) печінка з метастазами; 2) жовчний міхур; 3) новоутворення шлунка; 4) локальний рецидив?
8. Клінічні дані:
9. Клінічний діагноз: GIST шлунку. Метастази в печінку. Стан після терапії іматінібом.

Прізвище лікаря: Остапишен О.М.
Підпис _____

Дата та час надходження матеріалу: 22.09.26
Кількість шматочків: 30 Кількість блоків: 20 Методика забарвлення: гем-еозин, ІГХ.

Макроскопічний опис: 1) пухлина шлунку розміром 4,9х3,5х3 см з ділянкою стінки. На розрізі сіро-зеленуватого кольору з жовтими прошарками. Краї резекції шлунку прошиті металевими скобками. Біля шлунку ділянка жирової клітковини малого чепця з одиничним ущільненням; 2) окремо фрагмент жирової тканини з очеревиною(?) з ділянкою ущільнення; 3) Ж/м 6х3 см з міхуровою протокою довжиною 2 см; 4) Фрагмент печінки 20х18х9 см. На розрізі пухлина 18з16х9 у вигляді кістозної порожнини з каламутним серозно-геморагічним вмістом. Вздовж стінок плівчасті нашарування жовтого кольору. Стінка на більшому протязі представлена тканиною сіро-зеленуватою кольору, що схожа на пухлину шлунку. На фоні цього наявні округлі осередки світло-рожевої тканини розміром від 0,5 до 1,5 см у кількості до 10 шт., схожої на вітальну пухлину. В оточуючій тканині печінки, поруч з першим вузлом, додаткове вогнище 6х4х4см, аналогічної будови – сіро-зеленувата тканина з округлими осередками збереженої пухлинної тканини від 0,5 до 1,5 см.

Маркування препаратів: блок №1 – пухлина + край резекції шлунка, №2-5 – пухлина шлунку; №6 – ж/к малого чепця біля стінки шлунку; №7-8 – ж/к з ущільненням, №9 – ж/м, №10-14 – осередки збереженої тканини пухлини у стінці кістозної пухлини печінки, №15-17 – додаткове вогнище у печінці, №18 – край резекції основної пухлини, №19 – рихлі маси в просвіті кісти, №20 – печінка без пухлини, №cito 699-700/26 – вузол з очеревини, вогнище в печінці після експрес-гістології.

Результати імуногістохімічного дослідження:
Проведено на пухлині шлунку, блок №4488-1/26
CD117/c-kit (RM359) – слабка реакція в окремих групах клітин (до 1%);
DOG-1 (DOG1.1) – негативна реакція;
Ki-67 (MIB-1) – 0%.
Проведено на одному з вогнищ збереженої тканини пухлини в печінці, блок №4488-14/26
Ki-67 (MIB-1) – вогнищево 15%.
Проведено на матеріалі вузла у жировій клітковині фрагменту малого чепця біля стінки шлунку блок №4488-6/26
β-catenin (β-catenin-1) – позитивна ядерна реакція у фібробластах;
Проведено на матеріалі вузла у жировій клітковині, що надіслано окремо, блок №4488-7/26

β-catenin (β-catenin-1) – позитивна ядерна реакція у фібробластах;
Проведено на матеріалі вузла у матеріалі утворення, що було надіслано на експрес-гістологію, блок №cito699/26
β-catenin (β-catenin-1) – позитивна ядерна реакція в частині фібробластів в одному з полів зору;
DOG-1 (DOG1.1) – негативна реакція;
CD68 (KP-1) – позитивна реакція в скупченнях макрофагів.

Патогістологічний висновок:

1. Гастроінтестинальна стромальна пухлина (GIST) шлунку, веретеноклітинний варіант з явищами лікувального патоморфозу IIIст. (визначаються поодинокі групи CD117-позитивних клітини на фоні гіалінізованої тканини, що займають до 1% об'єму). У лімфатичних вузлах прилеглого фрагменту малого чепця – реактивна гіперплазія (2 шт.). У тканині печінки метастази гастроінтестинальної стромальної пухлини шлунку, High Grade (мітотичний індекс >5/50 полів зору x400), у вигляді двох поруч розташованих утворень: одне з них з вираженою кістозною трансформацію, друге у вигляді солідного вузла. В обох метастатичних вогнищах на фоні поширених ділянок гіпоклітинного гіалінозу (прояв лікувального патоморфозу) наявні осередки збереженого пухлинного росту. Лікувальний патоморфоз пухлин печінки II-IIIст. Краї резекції по тканині печінки та шлунку без ознак пухлинного росту (R0). Хронічний атрофічний холецистит, у лімфатичному шийки жовчного міхура (1шт.) – явища синусового гістіоцитозу.
   ypT2 ypN0(0/2) ypM1(hep), High Grade, R0. ICD-O-4 code 89360/3.
2. У жировій клітковині малого чепця поруч зі стінкою шлунку, в окремо надісланому фрагменті жирової клітковини та у фрагменті тканини, що була надана на експрес-гістологію – осередки росту десмоїдного фіброматозу. ICD-O-4 code 88210/1.

Коментарі:

1. Аналіз медичної літератури показав окремі публікації, що присвячені виникненню десмоїдного фіброматозу у пацієнтів з GIST, як на момент первинної діагностики, так і після проведеного лікування.
2. По матеріалу попередньо-проведеної трепан-біопсії пухлини печінки був виставлений Low Grade. По даному матеріалу ми виставляємо High Grade, так як наявні окремі зони явно підвищеної мітотичної активності. Ці зони не були присутні у матеріалі трепан-біопсії.

Дата дослідження: 02.11.26

Прізвище патологоанатома: Нікандрова Н.В. підпис_____

Прізвище патологоанатома: Кропельницький В.О. підпис_____

Перелік літератури:

1. A. G. Dumont et al. Simultaneous gastrointestinal stromal tumor (GIST) and desmoid fibromatosis (DF). J Clin Oncol 27, 10568-10568(2009). DOI:10.1200/jco.2009.27.15_suppl.10568
2. Dumont AG, Rink L, Godwin AK, et al. A nonrandom association of gastrointestinal stromal tumor (GIST) and desmoid tumor (deep fibromatosis): case series of 28 patients. Ann Oncol. 2012 May;23(5):1335-1340. doi: 10.1093/annonc/mdr442. Epub 2011 Oct 12. PMID: 21994214; PMCID: PMC3493136.
3. Murshid, Areen Abdulelah, Al-Maghraby, Hatim Q., Subsequent Development of Desmoid Tumor after a Resected Gastrointestinal Stromal Tumor, Case Reports in Pathology, 2018, 1082956, 5 pages, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/1082956
4. Chunhui Wu et al. Identifying intra-abdominal desmoid type fibromatosis mimicking recurrence/metastasis of GISTs using FAPI PET/CT.. J Clin Oncol 42, e23516-e23516(2024). DOI:10.1200/JCO.2024.42.16_suppl.e23516
5. Wang, X., Shou, C., Zhu, K., et al. New Abdominal Mass After Surgery for Gastrointestinal Stromal Tumor: Desmoid-Type Fibromatosis Difficult to Distinguish from Mesenchymal Tumor – A Case Report. International Medical Case Reports Journal, 2024, 17, 965–969. https://doi.org/10.2147/IMCRJ.S488459